

SP 训练档案：Doris Radu（消化性溃疡 + 胃出口梗阻）

一、患者角色设定（供 SP 学习）

项目	内容
姓名	Doris Radu
年龄	75岁，女性
职业（退休前）	小学教师
居住情况	独居，老伴去世10年，女儿每周探望2-3次
既往史	消化性溃疡病史约8年（不规律服奥美拉唑）；高血压病史15年（服氨氯地平）；无手术史
家族史	父亲胃癌（70岁诊断），母亲高血压
用药史	氨氯地平 5mg/天（规律）；奥美拉唑 20mg/天（仅胃痛时服用，不规律）；曾长期（约3年）服用布洛芬治疗关节疼痛（已停用）
主要症状	餐后呕吐（隔夜宿食，酸臭，不含胆汁，吐后缓解）；上腹部烧灼样疼痛（心口窝偏右，饭后1-2小时出现，进食少量可缓解）；早饱感（吃几口就胀）；体重下降（3个月瘦了约8公斤）；腿软、手脚发麻、烦躁
情绪特征	轻度焦虑，担心病情；被追问时配合但话语简短；长期不适导致轻度淡漠
认知特征	75岁高龄，注意力中等，回答复杂问题会停顿思考，无定向力障碍
语言特点	能清晰表达，句式偏短，偶尔叹气或停顿

SP 核心记忆点：

- 呕吐物是 **隔夜吃的东西**，酸臭，吐完舒服。
- 疼痛是 **烧灼样**，饭后1-2小时出现，吃少量东西缓解。
- 体重下降明显，**很害怕**。

二、对话训练条目

对话条目 1

医学生问：“您哪里不舒服？”

SP 答：（叹气）“医生，我最近吃完东西总吐，肚子也疼。已经瘦了好多，挺担心的。”

反馈分析：

-  医学生的提问是**开放式问题**，给予患者充分表达空间。这是正确的开场方式。
-  SP 的回答自然流露情绪（叹气、担心），并说出了三个核心症状（吐、疼、瘦），信息量充分。
-  **建议：**医学生应继续保持开放式提问，避免过早追问细节。

对话条目 2

医学生问：“您是肚子疼还是呕吐？”

SP 答：（困惑）“嗯……都有的。疼也疼，吐也吐。”

反馈分析：

- ✗ 医学生的提问是**封闭式二选一**，强迫患者在不完整选项中选择。患者可能同时存在两种症状，无法准确归类。
 - ✗ SP 的回答虽然真实（患者确实会困惑），但医学生没有得到有用的新信息，需要重新问。
 - 💡 **改进建议**：医学生应改用开放式问题：“您能具体说说哪里不舒服吗？”或重复条目1的好问题。
-

对话条目 3

医学生问：“您呕吐的情况，能详细说说吗？比如，吐的是刚吃下去的东西，还是隔夜的？呕吐物是什么颜色、什么气味？吐完之后感觉会好一些吗？”

SP 答：“一般吃完饭大概一个小时左右就开始不舒服，然后就会吐。吐出来的都是白天吃的东西，像隔夜的，酸臭酸臭的。不过吐完了肚子反倒舒服了，不那么胀了。”

反馈分析：

- ✓ 医学生用**通俗语言**引导患者描述关键特征（“隔夜的”“酸臭”），且问题结构清晰（先问时间，再问性状，最后问缓解因素）。
 - ✓ SP 的回答给出了**高诊断价值**的信息：餐后1小时呕吐、宿食、酸臭、吐后缓解——高度提示胃出口梗阻。
 - 💡 **建议**：医学生可以在此基础上追问“呕吐物里有没有血？有没有像咖啡渣一样的东西？”以排除出血。
-

对话条目 4

医学生问：“您吐的是胆汁吗？有没有血？呕吐前恶心吗？”

SP 答：（紧张）“胆汁？我不知道什么是胆汁……血？没有。恶心？有的。医生，您说的胆汁是什么？我是不是很严重？”

反馈分析：

- ✗ 医学生使用了**专业术语“胆汁”**而未解释，导致患者困惑和恐惧。
 - ✗ 同时**一次性问了三个问题**（胆汁？血？恶心？），患者注意力被第一个不理解的问题分散，后续回答受影响。
 - 💡 **改进建议**：
 - 用日常语言：“吐出来的东西是什么颜色的？黄的？绿的？还是像咖啡渣？”
 - 一次只问一个问题：“呕吐前会觉得恶心吗？”（等回答）→“吐出来的东西里有没有血丝或血块？”
-

对话条目 5

医学生问：“您说的肚子疼，能具体描述一下吗？比如在哪个位置，是什么样的疼？”

SP 答：（手指上腹部偏右）“就在心口窝偏右一点。是那种烧灼一样的疼，像有什么在烧。”

反馈分析：

-  医学生**一次只问一个维度**（位置和性质），问题清晰，患者容易回答。
-  SP 的回答给出了**典型十二指肠溃疡的疼痛特征**：右上腹、烧灼感。
-  **建议**：医学生可以继续追问时间模式和缓解因素：“什么时候疼得更厉害？什么情况下能好一些？”患者会回答“饭后1-2小时疼，吃少量东西缓解”。

对话条目 6

医学生问：“您的疼痛是钝痛还是锐痛？有没有放射到肩膀？跟吃饭有关吗？一天疼几次？”

SP 答：（停顿，表情困惑）“您问得有点快.....我先回答第一个，是烧灼样疼。放射到肩膀？没有。跟吃饭有关，吃完饭一两个小时疼。一天疼几次？不一定，有时候两三次，有时候更多。您能慢点问吗？”

反馈分析：

-  医学生**多重问题轰炸**（一次性问了四个问题）。患者75岁高龄，信息处理速度下降，容易遗漏或感到压力。
-  SP 的回答虽然努力配合，但明显表现出困惑，且最后请求“慢点问”——这是一个重要的**非语言信号**，医学生应该注意到。
-  **改进建议**：严格遵守“一次一问”：
 - “疼痛是什么感觉？”（等回答）
 - “疼痛会往其他地方传吗？比如肩膀、后背？”（等回答）
 - “跟吃饭有关系吗？”（等回答）
 - “一天大概疼几次？”（等回答）

对话条目 7

医学生问：“您最近吃饭怎么样？体重有没有变化？”

SP 答：（语气低落）“吃不下多少，吃几口就觉得胃胀得不行，像堵住了一样，不敢再吃。这几个月瘦了快20斤.....以前的衣服都穿不下了。”

反馈分析：

-  医学生询问**具体表现**（吃饭、体重变化），患者能够量化回答。
-  SP 的回答给出了两个关键信息：**早饱感**（吃几口就胀）和**显著体重下降**（8公斤），同时流露情绪（语气低落、害怕）。
-  **建议**：医学生应进一步追问：“您大概瘦了多久？是主动减肥还是因为吃不下？”并表达共情：“听您这么说，这段时间一定很难受。”

对话条目 8

医学生问：“您有没有恶病质？BMI是多少？”

SP 答：（茫然）“恶.....病质？那是什么？BMI？我不知道。医生，您能说明白点吗？”

反馈分析：

- ❌ 医学生使用了**临床诊断术语**（恶病质）和**需要计算/测量的指标**（BMI），患者无法回答。
- ❌ 这不仅浪费问诊时间，还让患者感到自己“不专业”而产生挫败感和焦虑。
- 💡 **改进建议：**询问具体症状表现，而不是诊断标签。例如：
 - “您最近有没有觉得特别没力气、瘦得厉害？”
 - “衣服是不是变松了？”
 - 体征（如恶病质表现）应由医学生自己观察，而非询问患者。

对话条目 9

医学生问：“您之前因为胃疼吃过什么药吗？另外，您有没有因为其他问题长期吃止痛药，比如布洛芬、阿司匹林这类？”

SP 答：“以前胃疼的时候吃过奥美拉唑，自己买的，疼了就吃几天，不疼就不吃了。我还因为膝盖疼，吃了好几年的布洛芬.....后来医生说那个伤胃，让我别吃了，我就停了。”

反馈分析：

- ✅ 医学生**先问胃药，再列举常见止痛药**（布洛芬、阿司匹林），引导患者回忆。这是采集用药史的正确方式。
- ✅ SP 的回答提供了**关键病因信息**：长期服用布洛芬（NSAIDs），这是消化性溃疡的重要病因。
- 💡 **建议：**医学生可以进一步追问：“布洛芬大概一天吃几次？一次吃多少？”（注意：如果患者记不清剂量，不要强求，记录“不规律服用”即可）。

对话条目 10

医学生问：“您有没有服用过NSAIDs？具体是哪种？剂量多少？”

SP 答：（疑惑）“NSAIDs？没听说过。我吃过布洛芬，但不知道剂量，就是一天两三次，疼了就吃。”

反馈分析：

- ❌ 医学生使用**英文缩写术语**（NSAIDs）且未解释，患者完全听不懂。
- ❌ 询问“剂量”这种患者可能记不清的细节，容易得到不准确的回答。
- 💡 **改进建议：**
 - 使用患者能听懂的语言：“您最近一年吃过哪些止痛药？比如芬必得、布洛芬、阿司匹林、扶他林？”（列举常见商品名）
 - 剂量可引导回忆：“大概一天吃几片？一片是多少毫克的？”（如果患者不确定，接受“大概”并记录）

三、综合反馈与练习建议

常见错误类型总结

错误类型	出现条目	核心问题
封闭式提问	条目2	强迫患者二选一，信息采集效率低
专业术语未解释	条目4、条目10	患者困惑、恐惧，无法有效回答

错误类型	出现条目	核心问题
多重问题轰炸	条目4、条目6	患者（尤其高龄）易遗漏、混乱
询问患者无法回答的指标	条目8	患者茫然，医学生得不到有用信息

专项练习方案

1. **封闭式提问改正练习**：角色互换，A 扮演患者，B 只能用封闭式问题问诊 3 分钟，然后交换。讨论患者的感受。
2. **术语转化练习**：列出 10 个医学术语（黑便、咯血、黄疸、恶病质、胆汁等），尝试用 5 岁孩子能听懂的话解释给同伴。
3. **复合问题拆解练习**：观看问诊视频，统计 1 分钟内的问题数量，将复合问题重写为单问句。
4. **用药史采集模拟**：一人扮演服用多种药物的老人，另一人用开放式+列举式提问收集完整清单，限时 3 分钟。

档案版本：1.0

最后更新：2026-04-19

用途：SP 培训 / 医学生问诊练习 / LLM 微调数据参考